

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (адсорбована)

Форма постачання - флакон з вакциною, оснащеною індикатором або без нього

Флакон з вакциною, оснащений індикатором.....(необов'язково)	
✓	Внутрішній квадрат світліший за зовнішнє коло. Якщо термін придатності не закінчився, ВИКОРИСТОВУЙТЕ вакцину
✓	Пізніше внутрішній квадрат все ще залишається світлішим за зовнішнє коло. Якщо термін придатності не закінчився, ВИКОРИСТОВУЙТЕ вакцину
✗	Показник утилізації, Внутрішній квадрат збігається з кольором зовнішнього кола. НЕ використовуйте вакцину
✗	За межами показника (точки) утилізації: Внутрішній квадрат є темнішим за зовнішнє коло. НЕ використовуйте вакцину



Індикатор на флаконі з вакциною (VVM) є частиною етикетки. Кольорова точка, яка з'являється на етикетці флакону, є індикатором флакону з вакциною. Це термочутлива до часу* точка, яка вказує на кумулятивну температуру, якої зазнав флакон з вакциною. Дана точка попереджає кінцевого користувача про те, що вплив температури ймовірно може погіршити вакцину понад допустимий рівень.

Інтерпретація показника індикатора на флаконі з вакциною є простою. Зосередьтеся на центральному квадраті. Його колір буде поступово змінюватися. Допоки колір цього квадрата залишається світлішим за колір кола, вакцину можна використовувати. Як тільки колір центрального квадрата збігається з кольором кола чи стає темнішим за нього, флакон слід утилізувати.

Посилання

1. ВООЗ, листок-вкладиш до типової упаковки
2. Щотижневий епідеміологічний бюлетень, № 18, 7 травня 1999 року. Сторінка 139.

Для використання зареєстрованим практикуючим лікарем або лікарнею чи лабораторією
Вироблено компанією
Biological E. Limited
Corporate Address: 18/1 та 3, Азамабад, Хайдарабад - 500 020
Андхра-Радеш, ІНДІЯ
Веб-сайт: www.biologicale.com

1. Опис

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (адсорбована) містить очищені дифтерійний і правцевий анатоксини та інактивовані мікроорганізми кашлюку. Вакцина адсорбована на фосфаті алюмінію в якості допоміжної речовини, а тіомерсал використовується в якості консерванту. Вакцина має вигляд білувато-каламутної суспензії. Вакцина відповідає вимогам ВООЗ.

2. Склад

Кожна доза об'ємом 0,5 мл містить:

Правцевий анатоксин	25 Lf ¹ (≥ 30 МО)
Правцевий анатоксин	5,5 Lf (≥ 60 МО)*
V.Pertusis (паличка Борде кашлюка)	16 МО (≥ 4,0 МО)**
Адсорбована на фосфаті алюмінію (AlPO ₄)	≥1,5 мг
Консервант Тіомерсал	0,01% м/об

¹Lf - флокулююча одиниця токсину

* ≥40 МО під час тестування на морських свинках та ≥60 МО під час тестування на мишах

** Нижня межа довірчого інтервалу (p=0,95) передбачуваної активності вмісту діючої речовини єна одиницю дозування становить не менше 2,0 МО.

3. Лікарська форма

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (адсорбована) (АКДП) - це білувато-каламутна суспензія для внутрішньом'язового введення ін'єкцій.

4. Клінічні характеристики

4.1. Терапевтичні показання

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (адсорбована) (АКДП) призначена для первинної імунізації немовлят віком старше шести тижнів проти дифтерії, правця та

кашлюку. Вакцину можна безпечно та ефективно вводити одночасно з вакцинами БЦЖ, проти кору, поліомієліту (ОПВ та ІПВ), гепатиту В, жовтої гарячки, гемофільної інфекції типу b, а також з прийомом вітаміну А.

4.2. Режим дозування та спосіб застосування

З метою первинної імунізації рекомендується вводити 3 дози по 0,5 мл вакцини АКДП внутрішньом'язово з 4-тижневим інтервалом між дозами для немовлят віком старше шести тижнів. Флакон з вакциною слід добре збовтати для гомогенізації суспензії. Передньолатеральна ділянка верхньої частини стегна є найкращим місцем для введення ін'єкції (ін'єкція в сідницю дитини може призвести до травмування сідничного нерва, а тому не рекомендується). Не можна вводити препарат під шкіру, оскільки це може спричинити місцеву реакцію. Під час курсу первинної імунізації ін'єкцію не слід вводити більше одного разу в одне й те саме місце. Першу дозу слід вводити приблизно у віці 6 тижнів. Для кожної ін'єкції слід використовувати стерильну голку та стерильний шприц. Особливу увагу слід приділяти тому, щоб ін'єкція не потрапила в кровоносну судину.

4.3 Імунна недостатність

Осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як із симптомами, так і безсимптомно, необхідно вакцинувати АКДП відповідно до стандартного календаря щеплень.

4.4. Побічні реакції

Легкі місцеві реакції, наприклад, біль, відчуття болю та почервоніння, є поширеними і можуть бути пов'язані з підвищенням температури (38°C-39°C) та утворенням в місці введення ущільнення діаметром 3-4 см. Інші реакції, які можуть спостерігатися, включають озноб, дративливість, постійний плач у немовлят. У більшості випадків реакції тривають від 24 до 48 годин. У такому випадку слід розглянути можливість застосування жарознижувальних засобів, а у випадку місцевої реакції - холодних компресів. Іноді на місці ін'єкції може утворитися вузлик, але це не має жодних шкідливих наслідків. Більш серйозні реакції, такі як гарячка вище 40°C, надмірний крик та енцефалопатичні симптоми (наприклад, судоми) також можуть спостерігатися, проте вкрай рідко. За умови суворого дотримання перелічених нижче протипоказань кількість таких ускладнень буде зведено до мінімуму. Рідко надходили повідомлення про анафілактичні реакції та випадок смерті після прийому препаратів, що містять АКДП. У поодиноких випадках повідомлялося про полірадикулонеуропатію.

4.5. Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента вакцини є протипоказанням для застосування вакцини. Протипоказано застосовувати цю вакцину особам, у яких розвинулася негайна анафілактична реакція на попередню дозу або на будь-який компонент вакцини.

Протипоказанням для введення цієї вакцини є наявність будь-яких неврологічних станів, що розвиваються. АКДП не слід вводити дітям з будь-яким порушенням згортання крові, включаючи тромбоцитопенію, що є протипоказанням для внутрішньом'язового введення ін'єкції.

Не рекомендовано застосовувати вакцину для осіб віком від 7 років і старше.

Виникнення енцефалопатії після введення попередньої дози є протипоказанням для подальшого застосування. Імунізацію слід відкласти за наявності у немовляти гострого захворювання. Однак слабкий прояв гарячки, легкі респіраторні інфекції не повинні розглядатися як протипоказання.

4.6. Спеціальні попередження та застереження щодо застосування

Якщо при отриманні АКДП відбувається будь-яка з наведених нижче подій, рішення про введення наступних доз вакцини необхідно ретельно зважити.

1. Підвищення температури 40°C протягом 48 годин із не встановлених причин.
2. Колапс або шокоподібний стан (гіпотонічно-гіпореактивний епізод) протягом 48 годин.
3. Постійний, безутішний плач тривалістю 3 години, що виникає протягом 48 годин.
4. Судоми з гарячкою або без неї, що виникають протягом 3 днів.

У разі виникнення гострої анафілактичної реакції на будь-який компонент вакцини необхідно негайно зробити ін'єкцію адреналіну (1:1000). Для запобігання побічним реакціям повинні бути вжиті всі відомі запобіжні заходи. Це включає вивчення історії хвороби пацієнта щодо можливої чутливості та виникнення в минулому будь-яких побічних реакцій на цю вакцину або подібні вакцини, історії попередньої імунізації та поточного стану здоров'я. Пацієнти з імуносупресією можуть не відреагувати на вакцину.

Проінформуйте пацієнта або опікуна пацієнта про переваги та ризики імунізації. Особливу увагу слід приділити тому, щоб ін'єкція не потрапила в кровоносну судину.

Для кожної дитини слід використовувати окремий шприц та голку. При поверненні дитини для отримання наступної дози в рамках серії імунізації, надзвичайно важливо опитати батьків або опікунів дитини щодо виникнення будь-яких симптомів та/або ознак побічних реакцій після введення попередньої дози.

4.7. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій

Як і під час застосування інших внутрішньом'язових ін'єкцій, необхідно з обережністю вводити препарат пацієнтам, які отримують антикоагулянтну терапію. Імуносупресивна терапія, включаючи опромінення, антиметаболіти, алкілюючі агенти, цитотоксичні препарати та кортикостероїди (у дозах, що перевищують фізіологічні), може знизити імунну відповідь на вакцину. Короткострокова (< 2 тижнів) терапія кортикостероїдами, внутрішньосуглобові ін'єкції кортикостероїдів у бурсу чи сухожилля не є імуносупресивними.

4.8. Вагітність і лактація

Не застосовується.

4.9. Небажані реакції

Часто спостерігаються легкі місцеві або загальні (системні) реакції. У значній частині випадків спостерігається тимчасовий набряк, відчуття болю та почервоніння в місці введення ін'єкції, що супроводжується підвищенням температури. Іноді протягом 24 годин після введення вакцини розвиваються тяжкі реакції у вигляді високої температури (з ознобом або без нього), появи дратівливості та крику. Повідомлялося про гіпотонічно-гіпореактивні епізоди. Повідомлялося про виникнення фебрильних судом з частотою один випадок на 12500 введених доз. Застосування ацетамінофену під час та через 4-8 годин після вакцинації зменшує подальшу частоту виникнення фебрильних реакцій.

Національне дослідження з питань дитячої енцефалопатії у Сполученому Королівстві показало незначне підвищення ризику гострої енцефалопатії (первинних судом) після імунізації вакциною АКДП. Однак подальші детальні аналізи всіх наявних досліджень, проведені низкою груп, зокрема Інститутом медицини США, Консультативним комітетом з практики імунізації та Педіатричною асоціацією Австралії, Канади, Сполученого Королівства та США, дійшли висновку, що дані не демонструють причинно-наслідкового зв'язку між вакциною АКДП та хронічною дисфункцією нервової системи у дітей. Таким чином, немає жодних наукових доказів того, що ці реакції мають будь-які постійні наслідки для дітей¹.

Рідко повідомлялося про анафілактичні реакції та смерть після введення препаратів, що містять АКДП. Повідомлялося про поодинокі випадки полірадикулонейропатії після введення вакцини, що містить правцевий анатоксин, як про можливу етіологію.

5. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці (зберігається за температури від 2°C до 8°C).

6. ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИНИ

Флакон з вакциною необхідно зберігати за температури від 2°C до 8°C протягом усього використання. Не заморожувати. Якщо вакцину заморожували, її слід утилізувати.

7. Інструкція щодо застосування/поводження:

Вакцина АКДП випускається у вигляді суспензії. При зберіганні може спостерігатися наявність білого осаду та прозорої надосадової рідини. Перед введенням вакцину слід добре збовтати для отримання однорідної каламутно-білої суспензії та візуально перевірити її на наявність сторонніх часток та/або зміни фізичних характеристик. У разі виявлення будь-якої з вищезазначених ознак вакцину слід утилізувати.

8. Форма випуску вакцини:

Рідка вакцина АКДП доступна у формі одноразової дози (0,5 мл)

Рідка вакцина АКДП доступна у флаконі, що містить десять доз (5 мл)